



Cours de résidanat 2025

Objectif n° 6

Arthrites septiques

Youssef Othman

Université de Monastir- Faculté de Médecine de Monastir



Madame M, âgée de 56 ans, hypertendue, est suivie depuis 2 mois pour une impotence fonctionnelle douloureuse partielle de l'épaule gauche. Une exploration par arthroscanner de l'épaule a montré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Des séances de rééducation lui ont été prescrits. Deux semaines après, elle consulte pour une exacerbation aiguë des douleurs qui sont devenues insomniantes rebelles au paracétamol et aux AINS. À l'examen la patiente est apyrétique, la moindre mobilisation de l'épaule est extrêmement douloureuse.

Vous suspectez une arthrite septique de l'épaule. Quel(s) examen(s) complémentaire(s) demandiez-vous en urgence pour mettre en évidence un épanchement articulaire:

- A. Un dosage de la C-reactive proteine
- B. Un arthroscanner de l'épaule
- C. Une arthrographie de l'épaule
- D. Une échographie de l'épaule
- E. Une IRM de l'épaule

Un épanchement de l'articulation gléno-humérale est mis en évidence. Quel(s) examen(s) complémentaire(s) vous permettra de confirmer le diagnostic d'arthrite septique?

- A. Une vitesse de sédimentation
- B. Une CRP
- C. Une ponction du liquide articulaire avec analyse cytbactériologique
- D. Une IRM de l'épaule
- E. Un PET scan

Aspect du liquide ponctionné



Concernant le modalité d'acheminement et d'analyse de ce liquide de ponction, quelle(s) est (sont) la(les) proposition(s) exacte(s)?

- A. L'échantillon doit être gardé à une température $<4^{\circ}\text{C}$ en attendant son acheminement au laboratoire
- B. Le liquide est envoyé pour analyse cytot bactériologique et pour analyse biochimique
- C. La quantité et l'aspect du liquide doivent être notés sur le dossier médical
- D. Un examen direct positif est nécessaire pour retenir le diagnostic d'arthrite septique
- E. L'échantillon est mis en culture pendant 5 jours au maximum

Résultat de l'analyse cytobactériologique et chimique

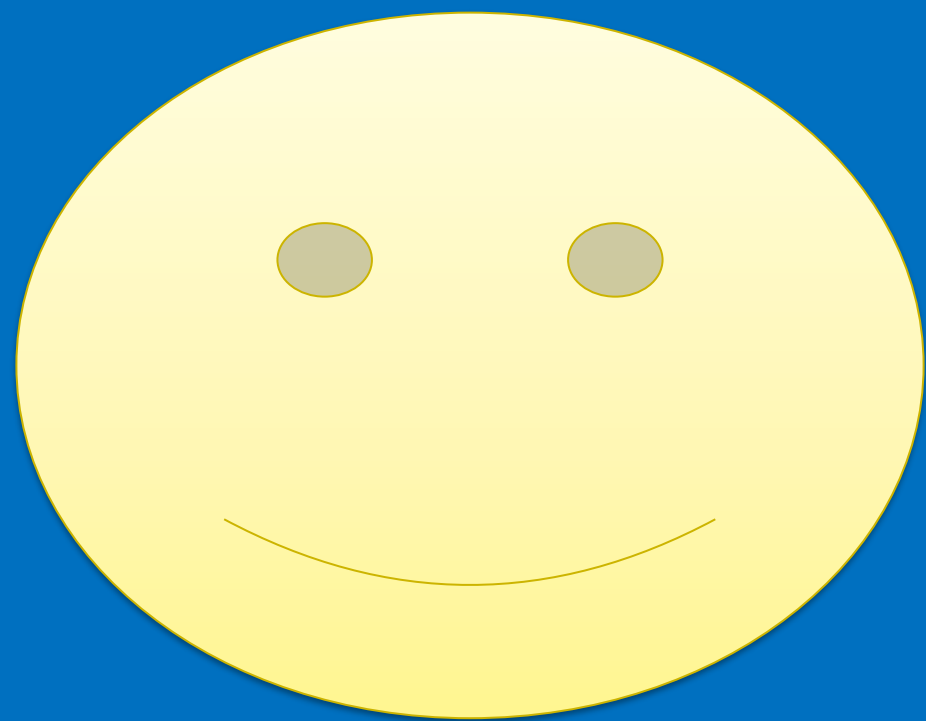
- Examen direct: négatif
- Leucocytes: 70 000 dont 95% des PNN altérés
- Protides: 43g/L
- Glucose: 0.6g/L

Quel(s) est(sont) l'(les) élément(s) de votre conduite à tenir?

- A. Surveillance de la température à domicile et refaire une ponction et des hémoculture si apparition de fièvre
- B. Hospitaliser la patiente pour surveillance de la température et du bilan inflammatoire en attendant les résultats de la culture
- C. Commencer immédiatement une antibiothérapie intraveineuse par oxacilline+gentamicine en milieu hospitalier
- D. Drainage chirurgical avec prélèvements peropératoires bactériologiques et histologiques
- E. Mettre la patiente sous colchicine pendant 15 jours

Quel est le mode de contamination le plus probable pour cette patiente?

- A. Contamination par contiguité
- B. Inflammation aigues causée par la rééducation
- C. Contamination par voie hématogène
- D. Contamination par voie lymphatique
- E. Contamination par inoculation



Monsieur S, un homme de 26 ans aux antécédents de diabète type 1, consulte aux urgences pour une plaie du genou droit suite à une agression par arme blanche. La plaie est illustrée par la figure suivante :



Votre attitude vis-à-vis cette plaie:

- A. Suture en salle de soins à vif
- B. Suture en salle de soins sous anesthésie locale
- C. Soins locaux et pansement stérile sans suture
- D. Suture en salle de soins et prescription d'antibiotique
- E. Exploration chirurgicale de la plaie au bloc opératoire

Une semaine après la première consultation, Monsieur S revient aux urgences pour une tuméfaction douloureuse du genou. L'examen trouve une fièvre à 39.5°C, une boiterie d'esquive et une augmentation du volume du genou.

Le diagnostic évoqué en premier lieu est:

- A. Une fracture ouverte de la patella
- B. Une bursite pré-patellaire
- C. Une tumeur infectée du genou
- D. Une arthrite septique du genou
- E. Une ostéomyélite aiguë de l'extrémité inférieure du fémur

Le mode de contamination pour ce patient est:

- A. Une contamination par voie hématogène
- B. Une contamination par inoculation
- C. Une contamination par contiguïté
- D. Une contamination par voie lymphatique
- E. Une contamination à partir d'une ostéomyélite adjacente

Pour confirmer votre suspicion, vous cherchez un épanchement articulaire du genou chez ce patient.

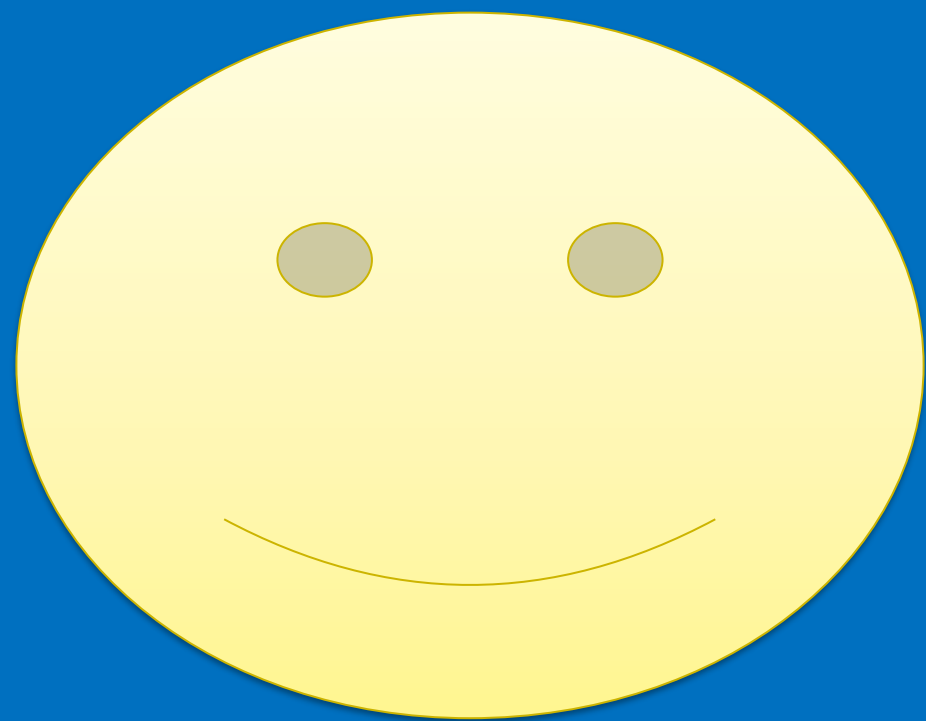
Le signe physique qui met en évidence cet épanchement est:

- A. la douleur à la palpation de l'interligne fémoro-patellaire
- B. le signe du choc patellaire
- C. la tuméfaction du genou
- D. la chaleur locale à la palpation du genou
- E. la douleur à la mobilisation passive douce du genou

Votre exploration trouve effectivement un épanchement articulaire abondant du genou.

L' (les) examen(s) complémentaire(s) indiqué(s) en urgence pour confirmer le diagnostic d'une arthrite septique est (sont):

- A. Un prélèvement bactériologique par écouvillonnage de la plaie
- B. Une échographie du genou
- C. Un hémogramme
- D. Un dosage de la C reactive protein
- E. Une ponction du genou avec étude chimique et bactériologique du liquide de ponction



Monsieur R, âgé de 27 ans, consulte pour une tuméfaction douloureuse fébrile des 2 genoux, de la cheville droite et poignet gauche. Vous suspectez une arthrite septique.

Quel(s) examen(s) complémentaire(s) demandez-vous en premier lieu aux urgences?

A. Une ponction du poignet gauche

B. Une hémoculture

C. Une IDR à la tuberculine

D. Un dosage du facteur rhumatoïde

E. Une recherche du génotype HLA B27

Le(s) germe(s) pouvant être responsable de cette arthrite septique est (sont):

- A. Staphylococcus aureus méti-S
- B. Staphylococcus aureus méti-R
- C. Streptococcus
- D. Nisseria gonorrhoeae
- E. Chlamydia trachomatis

Quel(s) élément(s) anamnestique(s) permet(tent) de réconforter l'hypothèse d'une arthrite septique gonococcique?

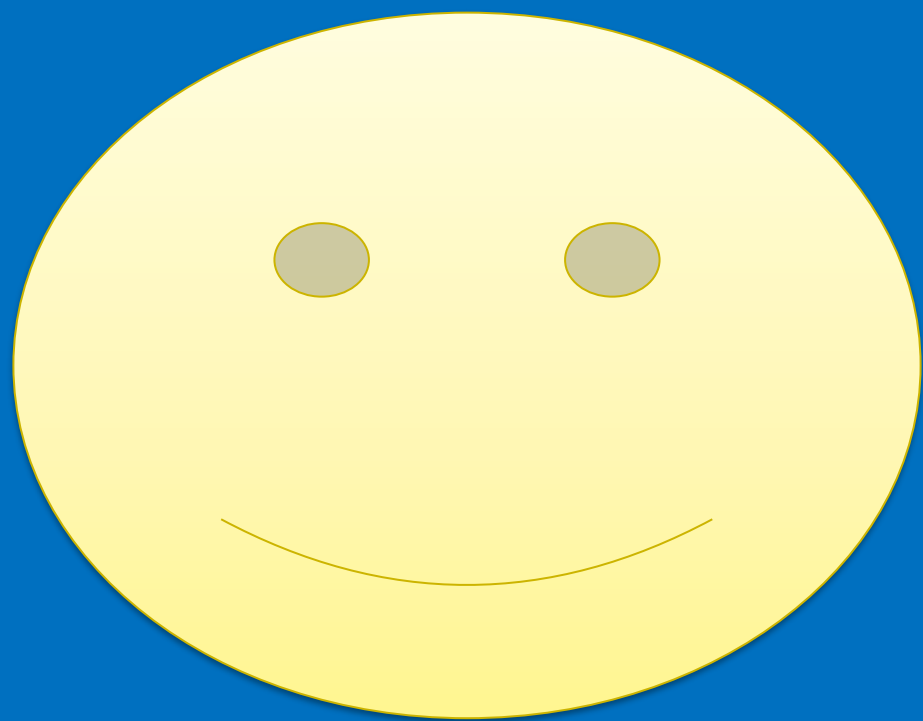
A. L'évolution des symptômes depuis 2 jours

B. La notion lésions dermatologiques récentes

C. La notion d'écoulement uréthral il y a 2 semaines

D. La notion de traumatisme fermé du poignet gauche il y a 10 jours

E. La notion de rapports sexuels avec partenaires multiples



Concernant la physiopathologie de l'arthrite septique:

- A. La membrane basale au niveau du tissu synovial permet de faciliter la fixation des germes et leur passage dans la cavité articulaire
- B. Les adhésines produites par les macrophages peuvent cause une destruction du cartilage
- C. Le cartilage est le premier tissu à être colonisé par les germes
- D. Les ligaments, la synoviale et le cartilage peuvent être lésés par les produits de la phagocytose
- E. La réaction inflammatoire peut être favorisée par les endotoxines bactériennes

Dans le cadre d'une arthrite septique, le syndrome inflammatoire biologique:

- A. Est toujours présent
- B. Permet de confirmer le diagnostic
- C. Permet de juger l'efficacité du traitement
- D. Permet de décider la durée de l'antibiothérapie
- E. Permet de décider le passage à l'antibiothérapie par voie orale

Dans le cadre d'une arthrite septique, la radiographie standard:

- A. Permet de visualiser les signes d'une atteinte cartilagineuse
- B. Peut montrer une luxation
- C. Peut montrer un épanchement articulaire
- D. Permet de guider la ponction articulaire au niveau du genou
- E. Montre toujours une pneumarthrose en cas de contamination par inoculation

Concernant les arthrites septiques sur prothèse du genou:

- A. Le mode de contamination est hématogène pour les formes post-opératoires précoces
- B. La forme clinique la plus fréquente est la forme suraigue toxique
- C. Les bactéries se fixent à la prothèse en constituant un biofilm
- D. Le drainage par ponctions itératives peut être envisager
- E. Le changement de la prothèse s'impose toujours

L'arthrite septique de la hanche:

- A. Est la localisation la plus fréquente chez l'adulte jeune bien portant
- B. Peut être secondaire à une ostéomyélite du col fémoral chez le nourrisson
- C. Est fréquente chez les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans
- D. Ne nécessite pas une antibiothérapie intraveineuse
- E. Peut se manifester par une luxation septique chez le nouveau-né

L'arthrite septique gonococcique:

- A. Peut être associée à des lésions cutanées
- B. Peut être associée à un écoulement génital
- C. Donne souvent des lésions cartilagineuses rapidement enraidissantes et irréversibles
- D. Est toujours multifocale
- E. Touche souvent les grosses articulations

Dans le cadre d'une arthrite septique du genou, l'immobilisation post-opératoire:

- A. Permet de diminuer les douleurs
- B. Est souvent assurée par une attelle en botte
- C. Est maintenue jusqu'à la fin de l'antibiothérapie
- D. Est au mieux réalisée dès l'admission avant la chirurgie
- E. Peut être compliquée par une thrombophlébite

La bactérie la plus fréquemment incriminée dans les arthrites septiques de l'adulte est:

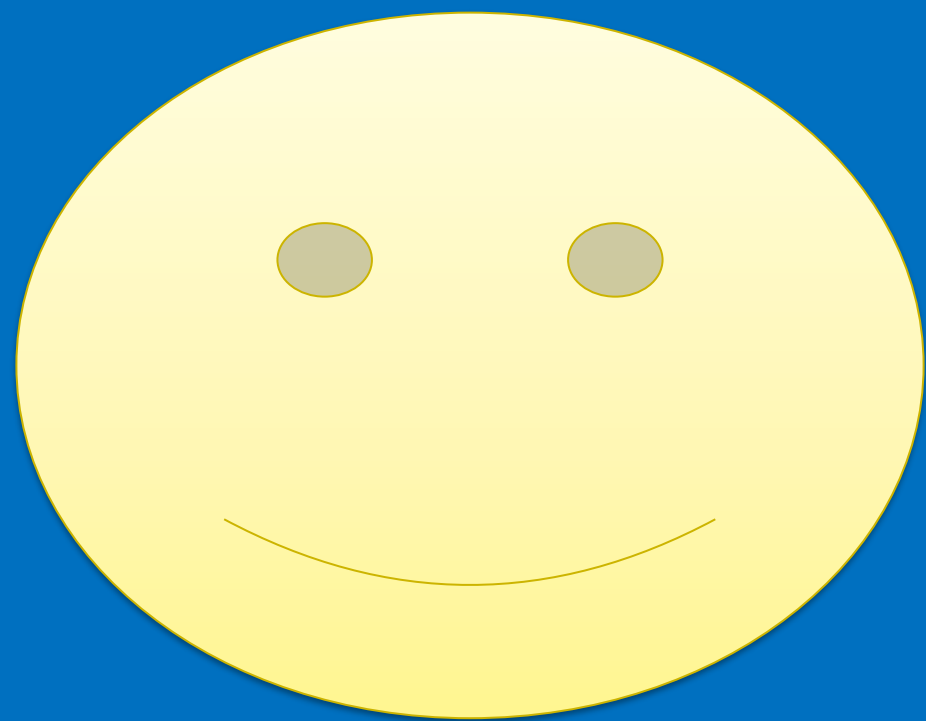
- A. *Haemophilus influenzae*
- B. *Streptococcus pneumoniae*
- C. *Staphylococcus aureus*
- D. *Pseudomonas aeruginosa*
- E. *Neisseria gonorrhoeae*

Monsieur M, 35 ans est hospitalisé pour une endocardite infectieuse. Lors de son hospitalisation, il a eu une arthrite septique du genou gauche. Chez ce patient, la contamination:

- A. est une contamination par contiguïté
- B. est une contamination par inoculation
- C. Est causée par un embole septique
- D. Est favorisée par une septicémie
- E. est une contamination hématogène

La (les) situation(s) suivante(s) favorise(nt) la survenue d'une arthrite septique:

- A. hypertension artérielle
- B. polyarthrite rhumatoïde
- C. traitement par anti-inflammatoires non stéroïdien par voie orale
- D. diabète
- E. insuffisance rénale terminale



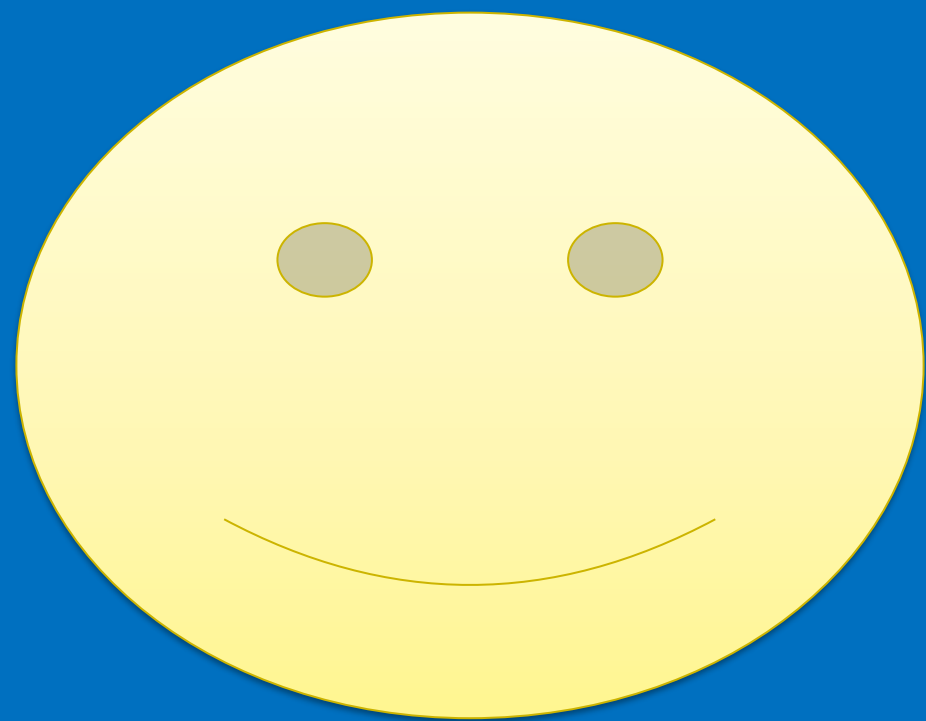
Madame R, âgée de 68 ans a eu une infiltration de corticoïdes au niveau de son épaule droite pour une omarthrose. Trois jours après, elle consulte pour une douleur fébrile de son épaule droite. La ponction du liquide articulaire ramène du liquide purulent.

Concernant le mode de contamination:

- A. L'omarthrose est un facteur favorisant la survenue de l'infection
- B. Il s'agit d'une contamination par inoculation
- C. Un défaut d'asepsie lors de l'infiltration peut causer cette infection
- D. Les corticoïdes injectées inhibent l'immunité locale au niveau de la synoviale articulaire
- E. C'est une contamination hématogène

Concernant la physiopathologie de cette complication:

- A. Le cartilage articulaire peut résister pendant des semaines à l'infection
- B. Le tendon long biceps peut être détruit par l'infection
- C. La membrane synoviale est le dernier élément à être colonisé par les bactéries
- D. L'aspect purulent du liquide ponctionné témoigne de l'activation de la phagocytose
- E. Le liquide articulaire contient des polynucléaires neutrophiles



Les données cliniques suivantes orientent vers une arthrite septique aiguë du genou:

A. La douleur est plus intense pendant la nuit

B. L'antécédent d'une arthroplastie par prothèse totale du genou

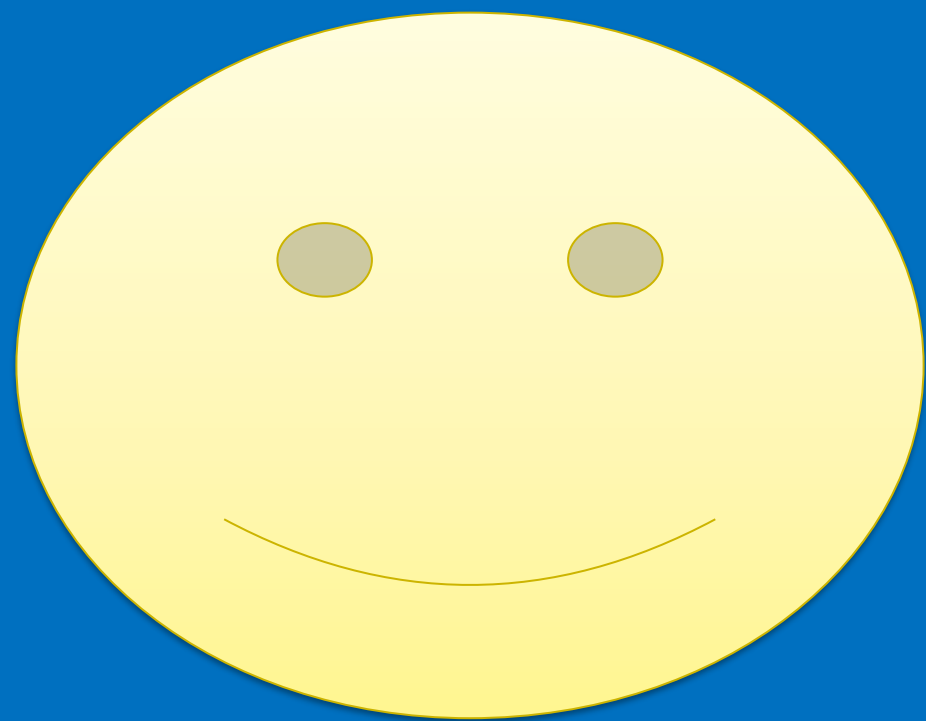
C. La douleur intéresse plusieurs articulations

D. L'impotence fonctionnelle totale

E. L'évolution des symptômes depuis 2 mois

Dans le cadre d'une arthrite septique aiguë, l'épanchement articulaire:

- A. est identifiable par l'examen physique au niveau du genou
- B. ne peut pas être ponctionné au niveau de l'épaule
- C. ne peut être mis en évidence que par une échographie chez l'enfant
- D. Peut se manifester par des signes indirects à la radiographie standard au niveau de la hanche
- E. Est un signe pathognomonique de l'arthrite septique



Mademoiselle F, 20 ans, consulte pour une monoarthrite aiguë du genou gauche. Quelles sont les propositions exactes concernant l'examen physique de cette patiente:

- A. La prise de la température est obligatoire
- B. Il faut examiner la hanche gauche
- C. Le test du choc patellaire recherche un abcès sous-périosté de la patella
- D. L'auscultation pulmonaire n'est pas indiquée
- E. La mesure de la pression artérielle n'a pas d'intérêt dans cette pathologie

L'examen physique de Mademoiselle F trouve une fièvre à 39°C, un épanchement du genou gauche et une tachycardie à 100 bpm. L' (les) examen(s) biologique(s) permettant de confirmer le diagnostic d'une arthrite septique en urgence est (sont):

- A. une vitesse de sédimentation
- B. une analyse macroscopique, cyto-bactériologique et biochimique du liquide articulaire
- C. un hémogramme
- D. une hémoculture
- E. Un dosage de la *C reactive protein* (CRP)

Vous décidez d'effectuer une ponction du genou pour Mademoiselle F.
Concernant le liquide ponctionné:

- A. Le liquide prélevé peut être conservé au froid pendant 24 heures au maximum
- B. La quantité du liquide ponctionné doit être notée
- C. La viscosité du liquide ponctionné est un élément du diagnostic étiologique
- D. La couleur jaune citrin du liquide ponctionné élimine la possibilité d'une arthrite septique
- E. La présence de sang dans le liquide ponctionné élimine le diagnostic d'une arthrite septique

Vous rédigez la demande d'analyse cyto-bactériologique du liquide ponctionné. Les analyses pertinentes pour confirmer le diagnostic d'une arthrite septique en urgence sont:

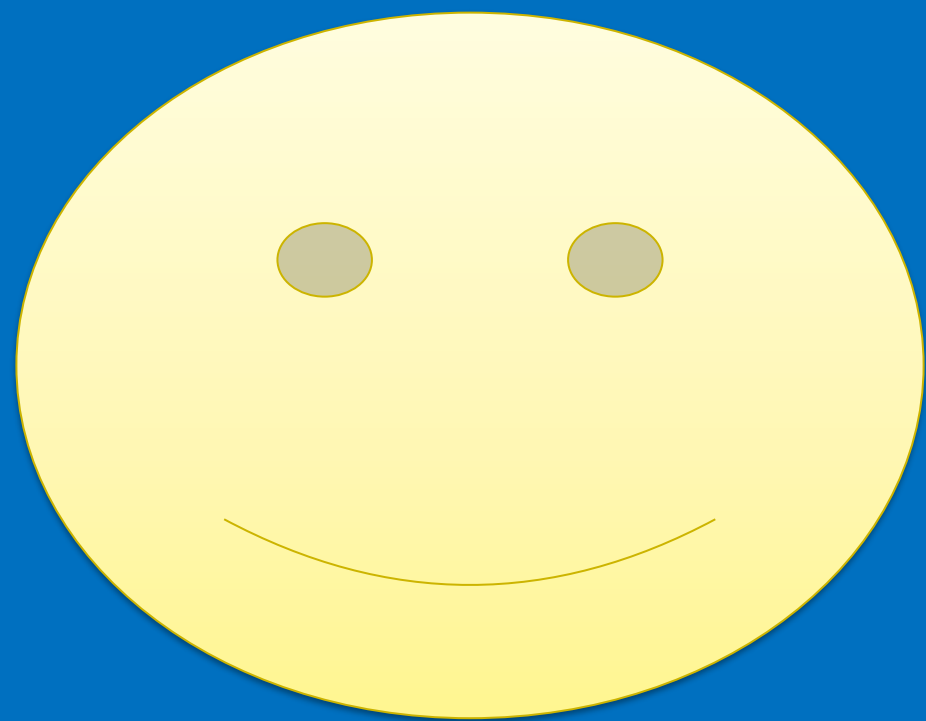
- A. un examen direct avec coloration de Gram
- B. Une formule leucocytaire avec identification du pourcentage des polynucléaires neutrophiles sans numération
- C. Une numération des leucocytes avec formule leucocytaire et recherche de polynucléaires altérées
- D. Une mise en culture du liquide articulaire
- E. Une recherche de bacille de Kock dans le liquide articulaire

L'analyse du liquide ponctionné chez Mademoiselle F trouve:

- Examen direct: absence de bactéries
- Leucocytes 70 000 éléments/mm³, dont 90% des PNN altérées
- Glucose à 0,2 g/L, Protides à 80 g/L
- Absence de micro-cristaux

Quelle antibiothérapie prescrivez-vous à cette patiente:

- A. Céfotaxime+fosfomycine
- B. Rifampicine seule en IV
- C. Ciprofloxacin+rifampicine
- D. Oxacilline+gentamycine
- E. Cotrimoxazol par voie orale

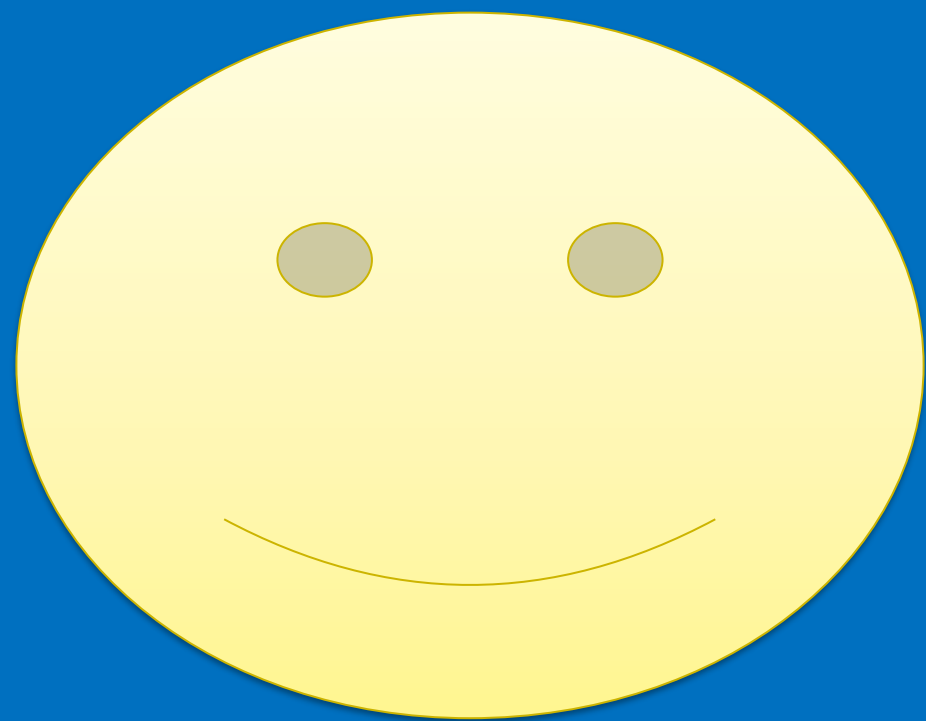


Chez le nourrisson, les éléments suivants font évoquer une arthrite septique de la hanche:

- A. La notion de prématurité
- B. Une asymétrie de la mobilité spontanée des membres inférieurs
- C. Une asymétrie des plis inguinaux
- D. La notion d'une voie veineuse centrale
- E. Une vaccination récente contre le tétanos

Une arthrite septique polyarticulaire est plus fréquente:

- A. Entre l'âge de 40 et 60 ans
- B. Chez le nouveau-né prématuré
- C. Chez les immunodéprimés
- D. En cas d'infection au staphylococcus aureus
- E. En cas de polyarthrite rhumatoïde



Monsieur B, 45 ans consulte pour l'inoculation d'une écharde de palmier au niveau de région supra-patellaire du genou droit. L'examen physique et l'échographie confirment l'absence de corps étranger. Le patient à son tour confirme que l'écharde a été retirée en totalité sur les lieux.

Une radiographie du genou droit de face et de profil a été demandée pour Monsieur B. le(s) signe(s) radiologique(s) qui fait (font) suspecter une effraction de la capsule articulaire est (sont)

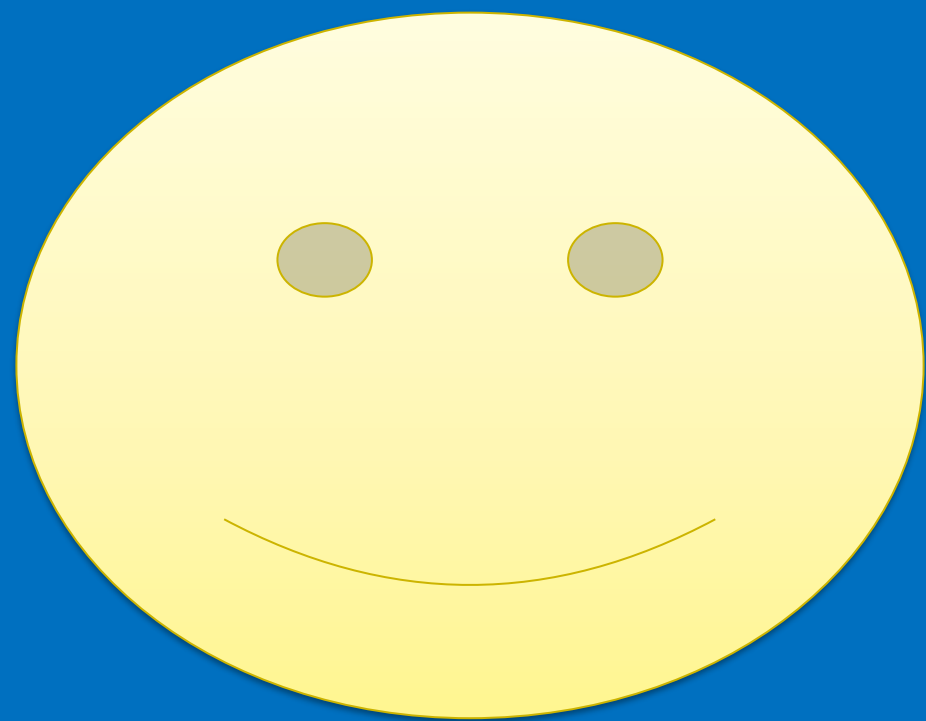
- A. Une lacune osseuse du plateau tibial
- B. Une pneumarthrose
- C. La présence de calcifications méniscales
- D. La présence d'ostéophytes marginaux
- E. La présence d'un pincement de l'interligne fémoro-tibiale médiale

La radiographie du genou est revenue normale. La conduite à tenir adaptée pour ce patient est:

- A. Des soins locaux et contrôle clinique dans 48 heures
- B. Des soins locaux, antibiothérapie prophylactique et contrôle clinique dans une semaine
- C. Une exploration et suture de la plaie sous anesthésie locale en salle des soins en respectant les règles d'asepsie
- D. Une exploration chirurgicale de la plaie au bloc opératoire
- E. Une antibiothérapie intra-veineuse en milieu hospitalier et surveillance étroite de la température

Monsieur B a finalement préféré de rentrer chez lui contre l'avis du médecin. Deux semaines après, il consulte pour un écoulement purulent à partir de la plaie. L' (les) élément(s) de l'examen physique qui vous fait (font) suspecter une arthrite septique plutôt qu'une simple infection de la plaie est (sont):

- A. Un test du choc patellaire positif
- B. Une fièvre supérieure à 39°C
- C. Une rougeur et une chaleur locale
- D. Une boiterie d'esquive
- E. Une douleur à la moindre mobilisation passive du genou



Madame K, 71 ans a été opérée il y a 25 jours pour une gonarthrose droite invalidante. Il lui a été fait une arthroplastie par prothèse totale du genou. Elle consulte pour une douleur persistante et un retard de cicatrisation de la plaie opératoire. L'examen trouve une température à 37,2°C, une impossibilité de marcher, un genou droit globalement tuméfié chaud à la palpation. La moindre mobilisation passive est extrêmement douloureuse. La plaie opératoire est humide faisant sortir des sérosités jaunâtres. Le test du choc patellaire est positif.

Le diagnostic suspecté en premier lieu est:

A. Une infection superficielle de la plaie opératoire

B. Une bursite pré-patellaire infectée

C. Une dermo-hypodermite

D. Une arthrite septique sur prothèse articulaire

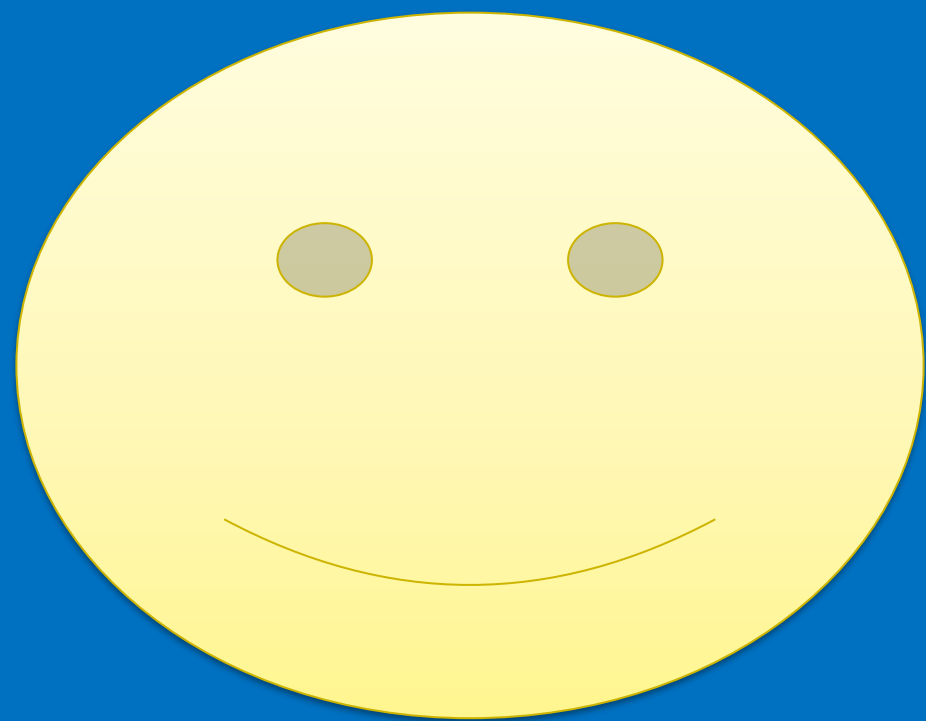
E. Une thrombophlébite surale

L'examen complémentaire à demander en premier lieu pour confirmer le diagnostic est:

- A. une radiographie du genou
- B. Une échographie du genou à la recherche d'une collection profonde
- C. Un dosage de la CRP
- D. Une ponction du liquide articulaire avec analyse cyto-bactériologique et biochimique du liquide ponctionné
- E. Une imagerie par résonnance magnétique du genou

Le diagnostic d'une arthrite septique sur prothèse du genou a été retenu pour Madame K. La stratégie thérapeutique adaptée en urgence est:

- A. une antibiothérapie intraveineuse à large spectre à commencer immédiatement
- B. Un drainage chirurgical suivi d'une antibiothérapie prolongée
- C. Un drainage chirurgical avec ablation de la prothèse suivis d'une antibiothérapie prolongée
- D. une antibiothérapie par voie orale avec contrôle clinique de la plaie dans une semaine
- E. Des ponctions quotidiennes du liquide articulaire



Concernant l'antibiothérapie dans le cadre d'une arthrite septique chez l'adulte:

- A. l'antibiothérapie probabiliste devant un examen direct négatif associe l'oxacilline et la gentamicine
- B. Une association à base de ceftriaxone et gentamicine est indiquée en cas d'identification de bacilles Gram négatif à l'examen direct
- C. En cas de culture négative, l'antibiothérapie est arrêtée
- D. une association à base d'oxacilline et gentamicine est indiquée si une porte d'entrée urinaire est retrouvée
- E. L'association fluoroquinolone rifampicine peut être utilisée en cas d'arthrite septique avec culture négative non améliorée par oxacilline gentamicine

Dans le cadre d'une arthrite septique, l'antibiothérapie probabiliste:

- A. doit être commencée dès la suspicion du diagnostic
- B. Doit être débutée après la ponction articulaire
- C. Doit être administrée en milieu hospitalier
- D. est débutée après l'obtention des résultats de la culture et de l'antibiogramme
- E. Est débutée après la prise de prélèvements bactériologiques lors du drainage chirurgical

Concernant le traitement chirurgical d'une arthrite septique:

- A. le drainage peut être réalisé par arthroscopie
- B. L'arthrotomie permet le drainage, l'exploration des lésions cartilagineuses et les prélèvements bactériologiques
- C. Le drainage chirurgical n'est pas indiqué chez l'enfant en absence de fièvre
- D. Le drainage chirurgical se fait habituellement après quelques jours de traitement antibiotique
- E. Un drain aspiratif est laissé en place après fermeture de la plaie opératoire